

TEMA 2.12 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Diabetes e Hipertensión Arterial

PERFIL EUNACOM 1.04.1.010
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipertensión Arterial en el Diabético

Objetivo de PA

TABLA 2.12.1: SITUACIÓN VS PA OBJETIVO	
SITUACIÓN	PA OBJETIVO
DM sin nefropatía	< 130/80 mmHg (de preferencia) / 140/90 (aceptable)
DM con nefropatía (microalbuminuria, macro o IRC)	< 130/80 mmHg (obligatorio)

Antihipertensivos: ¿cuál elegir?

TABLA 2.12.2: FAMILIA VS EN DM		
FAMILIA	EN DM	MOTIVO
IECAs o ARA-II	De elección	Nefroprotectores: ↓ proteinuria y progresión de nefropatía
Diltiazem (bloqueador Ca no-dihidropiridínico)	Complemento si hay albuminuria	↓ proteinuria adicional
Amlodipino (bloqueador Ca dihidropiridínico)	Complemento neutro	Ni beneficio ni daño renal
Tiazidas	Con precaución	↑ resistencia a insulina → puede descompensar glicemia
Beta-bloqueadores	Con precaución	Enmascaran síntomas simpáticos de hipoglicemia (piloerección, temblor, taquicardia)

EUNACOM CRITERIOS

Si hay insuficiencia cardíaca o ECV y se necesita beta-bloqueador → se usa igual (el beneficio cardiovascular supera el riesgo de enmascarar la hipoglicemia).

Resumen práctico

- Iniciar con **IECA o ARA-II** (de elección)
- Si se necesita 2º fármaco:
 - - Con albuminuria → agregar **Diltiazem**
 - - Sin albuminuria → agregar **Amlodipino**
- Evitar tiazidas como primer antihipertensivo en DM mal controlada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 58 años con DM2 e hipertensión arterial. Se detecta microalbuminuria en examen de orina. ¿Cuál es el antihipertensivo de primera elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diabetes e Hipertensión Arterial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 60-80% de los diabéticos tipo 2 tienen hipertensión arterial
- La meta de PA en diabéticos es menor a 130/80 mmHg
- IECA o ARA II son primera línea por su efecto nefroprotector
- Nunca combinar IECA con ARA II (riesgo de hiperkalemia e IRA)
- Segundo fármaco: amlodipino o tiazida en dosis baja
- Betabloqueadores enmascaran hipoglicemia y empeoran perfil metabólico
- IECA/ARA II están especialmente indicados si hay microalbuminuria

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL)

PREGUNTA 1

Paciente de 58 años con DM2 e hipertensión arterial. Se detecta microalbuminuria en examen de orina. ¿Cuál es el antihipertensivo de primera elección?

- A) Amlodipino 5 mg/día
- B) Enalapril 10 mg/día
- C) Atenolol 50 mg/día
- D) Hidroclorotiazida 25 mg/día
- E) Enalapril 10 mg + losartán 50 mg

PREGUNTA 2

Paciente diabético tipo 2 en tratamiento con enalapril 20 mg, aún con PA 145/90. ¿Cuál fármaco agregaría como segundo antihipertensivo?

- A) Losartán 50 mg
- B) Amlodipino 5 mg
- C) Propranolol 40 mg
- D) Hidroclorotiazida 50 mg
- E) Clonidina 0.1 mg

PREGUNTA 3

¿Por qué los betabloqueadores deben usarse con precaución en pacientes diabéticos?

- A) Producen nefrotoxicidad directa
- B) Enmascaran los síntomas de hipoglicemia
- C) Aumentan la proteinuria
- D) Producen hiperglicemia severa
- E) Están contraindicados con metformina

RESUMEN: DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La hipertensión arterial es una comorbilidad extremadamente frecuente en pacientes diabéticos, afectando al 60-80% de ellos. La coexistencia de ambas patologías multiplica el riesgo cardiovascular y acelera el daño de órgano blanco, especialmente la nefropatía diabética, la retinopatía y la enfermedad coronaria. La meta de presión arterial en pacientes diabéticos es menor a 130/80 mmHg según las guías actuales. El tratamiento farmacológico de primera línea son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II). Estos fármacos tienen el beneficio adicional de ser nefroprotectores al reducir la presión intraglomerular y la proteinuria. Están especialmente indicados cuando hay microalbuminuria o nefropatía diabética establecida. Nunca se deben combinar IECA con ARA II por riesgo de hiperkalemia e insuficiencia renal. Como segundo fármaco se pueden agregar bloqueadores de canales de calcio (amlodipino) o diuréticos tiazídicos en dosis bajas. Los betabloqueadores deben usarse con precaución ya que pueden enmascarar síntomas de hipoglicemia y empeorar el perfil metabólico, aunque están indicados si hay cardiopatía coronaria asociada. Los diuréticos tiazídicos en dosis altas pueden empeorar la resistencia a la insulina y la dislipidemia.